

Université de Constantine
Faculté de médecine
3^{ème} année de médecine
Module de sémiologie de l'appareil génital féminin
Pr K. MESGHOUNI

2024

Interrogatoire en gynécologie

Objectif pédagogique

S'avoir mené un interrogatoire en gynécologie
Connaitre le motif de consultation

PLAN

I. introduction

II. L'interrogatoire

2.1. Le motif de la consultation

2.2. Les antécédents

2.2.1. Les antécédents personnels

a) Les antécédents gynécologiques

b) Les antécédents médicaux

c) Les antécédents chirurgicaux

2.2.2. Les antécédents familiaux

2.2.3. Le conjoint

2.3. La symptomatologie fonctionnelle

I. introduction

Deux situations vont amener une patiente à « subir » un examen gynécologique :
— La patiente présente une pathologie qui nécessite un examen gynécologique, il s'agit donc d'une consultation dans le cadre d'une démarche diagnostique,
— La patiente ne présente pas de pathologie gynécologique, elle vient pour un examen gynécologique systématique, il s'agit alors d'une démarche de dépistage, s'adressant à une patiente ne présentant pas a priori, de pathologie

II. L'interrogatoire : Il s'agit d'un temps capital et indispensable.

L'interrogatoire a trois objectifs principaux :

- Déterminer le ou les motifs de la consultation,
- Répertorier les antécédents personnels et familiaux de la patiente,
- Faire décrire la symptomatologie fonctionnelle de la patiente.

2.1. Le motif de la consultation

- ✓ Parfois il s'agit d'une simple visite de surveillance dans le cadre d'un suivi gynécologique systématique, il n'y a donc pas de motif précis de consultation.
- ✓ Parfois il s'agit d'une pathologie précise qui amène la patiente à consulter.

- ✓ Ailleurs enfin, le motif est complexe, difficile à exprimer pour la patiente, c'est alors que l'expérience, le tact prennent toute leur importance

2.2 Les antécédents

Il faut tout d'abord préciser le milieu socioéconomique, l'âge et le contexte familial de la patiente.

2.2.1. Les antécédents personnels

a) Les antécédents gynécologiques

- Les antécédents physiologiques : de préciser les épisodes de la vie génitale de la femme des premières règles jusqu'à la ménopause.

— La ménarchie : correspond à l'apparition des premières règles. L'âge d'apparition des premières règles est variable, il se situe entre 10 et 16 ans (en moyenne vers l'âge de 12 à 13 ans).

— Le cycle menstruel : seront précisés :

- *le rythme* (normalement tous les 28 jours à 30 jours),
- *la durée des règles* (normalement 3 à 6 jours),
- *l'abondance des règles* (appréciée en demandant le nombre de garnitures nécessaires chaque jour : normalement abondantes les deux premiers jours, puis diminuent ensuite),

La date des dernières règles afin de dépister un début de grossesse, ce qui est capital, car en pratique, une grossesse au début contre-indique formellement certaines investigations notamment radiologique et isotopique et certains médicaments.

— Le nombre de grossesses et le nombre d'accouchements, le nombre d'enfants vivants, le nombre d'enfants décédés et la cause du décès, la recherche d'avortement, la recherche d'accouchement prématuré (au-delà du sixième mois de gestation), la notion d'enfant mort-né.

— La notion de contraception : *dispositif intra-utérin (stérilet), contraceptifs oraux, ligature des trompes.*

— La ménopause : *est la disparition définitive des règles ; elle correspond à l'arrêt de la fonction cyclique des ovaires. L'âge de la ménopause est très variable, il se situe entre 40 et 50 ans.*

- Les antécédents pathologiques :

— *Notion d'intervention sur le petit bassin : hystérectomie, intervention pour kyste de l'ovaire, césarienne.*

— *Des antécédents d'infection génitale*

b) Les antécédents médicaux

La recherche doit être guidée par le motif de la consultation. Noter la prise de médicaments, l'existence d'allergies, HTA, Diabète, Infectieux (VIH, hépatites B et C, syphilis, herpès). Psychiatriques

c) Les antécédents chirurgicaux

Plus particulièrement les antécédents de chirurgie gynécologique et digestive.

2.2.2. Les antécédents familiaux

— *De maladies générales : diabète, HTA, hypercholestérolémie familiale, pathologie thromboembolique ou cardio-vasculaire,*

— *Pathologie tumorale : cancer du sein et cancer pelvien,*

— *Pathologies en rapport avec une maladie familiale génétique.*

2.2.3. Le conjoint

Nombre de partenaires, changement de conjoint, pathologie du ou des conjoints.

Au terme de cet entretien, le gynécologue doit déjà savoir si la patiente appartient à un groupe à risque pour certaines pathologies ou si elle présente des contre-indications à certains traitements gynécologiques.

2.3 La symptomatologie fonctionnelle

Il peut être à l'origine de nombreuses pathologies gynécologiques :

- Stérilité et fertilité ;
- Cancers génitaux ;
- Maladies sexuellement transmissibles ;
- Problèmes de règles ;
- Problèmes de saignements ;
- Troubles de la sexualité ;
- Problèmes de douleurs ;
- Pathologies liées à la grossesse.
- La pathologie mammaire

CONCLUSION

L'interrogatoire est un temps capital de l'examen en gynécologie, qui permet de préciser le motif, les antécédents personnels et familiaux ainsi que la symptomatologie fonctionnelle

Référence et bibliographie

1. GERARD Pierre. Fiche sémiologique, pp275
2. Rose marie Hamladji. *Précis de Sémiologie, sémiologie de l'appareil génital*, pp 311-317
3. Baptiste Coustet. Sémiologie médicale, point important de l'anamnèse, PP363-4
4. Université Pierre et Marie Curie Gynécologie Niveau DCEM2 ; PP17- 19